

กรณีศึกษาที่ 2

สมรรถนะ RDU ของบัณฑิต

1. สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา
 - 1.1 การประเมินประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา และประวัติการแพ้ยา/แพ้ อาหาร
 - 1.2 ประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
 - 1.3 ประเมินอาการที่ดีขึ้นหรือเลวลง
 - 1.4 ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา อย่างต่อเนื่อง
 - 1.5 การส่งต่อ
2. สามารถร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น
 - 2.1 พิจารณาข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยาหรือการรักษาแบบไม่ใช้ยาในการรักษา และการส่งเสริมสุขภาพ
 - 2.2 พิจารณาข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยเพื่อประกอบการปรับขนาดยา หยุดการให้ยา หรือเปลี่ยนยา
 - 2.3 ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยาและไม่ใช้ยา
 - 2.4 ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ของยาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยต่อไปนี้ เช่น พันธุกรรม อายุ ความพร้อมของไต การตั้งครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
 - 2.5 พิจารณาโรคร่วม ยาที่ใช้อยู่ การแพ้ยา ข้อห้ามการใช้ยา และคุณภาพชีวิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้ยา
 - 2.6 คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วย (เช่น ความสามารถในการกลืนยา ศาสนา) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการบริหารยา
 - 2.7 พัฒนาความรู้ให้เป็นปัจจุบัน ใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ในการพิจารณาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 - 2.8 เข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยา แนวทางการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา (antimicrobial stewardship measures)
3. สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการใช้ยา โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและเคารพในมุมมองของผู้ป่วย
 - 3.1 ชี้แจงทางเลือกในการรักษา ยอมรับ ในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาและ เคารพในสิทธิของผู้ป่วย/ผู้ดูแล ในการปฏิเสธและจำกัดการรักษา
 - 3.2 ระบุและยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวัง เกี่ยวกับสุขภาพ และการรักษาด้วยยา
 - 3.3 อธิบายเหตุผล และความเสี่ยง/ประโยชน์ของทางเลือกในการรักษาที่ ผู้ป่วย/ผู้ดูแล เข้าใจได้

3.4 ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ด่วนตัดสินและเข้าใจเหตุผลในการไม่ร่วมมือของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้และหาวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนผู้ป่วย/ผู้ดูแล

3.5 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย/ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยไม่คาดหวังว่าการสั่งยานั้นจะเป็นไปตามที่ต้องการ

3.6 ทำความเข้าใจกับการร่วมปรึกษาหารือก่อนใช้ยาเพื่อผลลัพธ์ที่นำไปสู่ ความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4. บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง

4.1 เข้าใจโอกาสที่จะเกิดผลไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา และดำเนินการเพื่อ หลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตรวจจับและจัดการแก้ไขปัญหา

4.2 เข้าใจการสั่งจ่ายยาของแพทย์ตาม กรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

4.3 ตรวจสอบและคำนวณการใช้ยาให้ ถูกต้อง

4.4 คำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดการใช้ยาผิด (เช่น ผิดขนาด ผิดทาง ผิดวิธี ผิดชนิด ผิด วัตถุประสงค์ ฯลฯ)

4.5 ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ยา อย่างสมเหตุผล (เช่น การเก็บรักษา การ บรรจุ ฯลฯ)

4.6 ใช้ระบบที่จำเป็นเพื่อการบริหารยา อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ใบMAR)

4.7 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับยาและการใช้ ยาแก่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องมีการส่งต่อข้อมูล การรักษา

5. สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ (Provide information)

5.1 ตรวจสอบความเข้าใจและความ มุ่งมั่นตั้งใจของผู้ป่วย/ผู้ดูแลในการจัดการ เฝ้าระวังติดตาม และการมาตรวจตามนัด

5.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ชัดเจน เข้าใจ ได้ง่าย และเข้าถึงได้กับผู้ป่วย/ผู้ดูแล (เช่น ใช้เพื่ออะไร ใช้อย่างไร อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น รายงานอย่างไร ระยะเวลาของ การใช้ยา)

5.3 แนะนำผู้ป่วย/ผู้ดูแลเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเรื่องยาและการ รักษา

5.4 สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแล ว่าจะจัดการอย่างไรในกรณีที่มีอาการไม่ดีขึ้น หรือการรักษาไม่ก้าวหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด

5.5 สนับสนุนผู้ป่วย/ผู้ดูแลให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการตนเองเรื่องยาและภาวะเจ็บป่วย

6. สามารถติดตามผลการรักษา และรายงานผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาได้

6.1 ทบทวนแผนการบริหารยาให้ สอดคล้องกับแผนการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ

6.2 ต้องมีการติดตามประสิทธิภาพของการรักษาและอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ยา

6.3 ค้นหาและรายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้ระบบการรายงานที่เหมาะสม

6.4 ปรับแผนการบริหารยาให้ตอบสนองต่ออาการและความต้องการของผู้ป่วย

7. สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม (Prescribe safely)

7.1 รู้เกี่ยวกับชนิด สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อย และ วิธีการป้องกัน การหลีกเลี่ยง และการประเมิน

7.2 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งยาผ่านสื่อหรือบุคคลอื่น เช่น สั่งทาง โทรศัพท์ ทาง E-mail ทาง Line หรือสั่งผ่านบุคคลที่สาม และหาแนวทางลดความเสี่ยงนั้น

7.3 บริหารยาอย่างปลอดภัยตามกระบวนการบริหารยา เช่น 7 rights

7.4 พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการใช้ยา

7.5 รายงานความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา และทบทวนการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

8. สามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และเป็นไปตามหลักเวชจริยศาสตร์ (Prescribe professionally)

8.1 มั่นใจว่าพยาบาลสามารถสั่งจ่ายยาได้ ตาม พรบ.วิชาชีพและ พรบ.ยาแห่งชาติ

8.2 ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการสั่งยาและเข้าใจในประเด็นกฎหมายและจริยธรรม

8.3 รู้และทำงานภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสั่งยา (ยาที่ควบคุม ยาที่ไม่มีใบอนุญาต ยาไม่มีฉลาก)

9. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง (Improve prescribing practice)

9.1 สะท้อนคิดการบริหารยาของตนเอง และการสั่งยาของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

9.2 เข้าใจและใช้เครื่องมือหรือกลไกที่เหมาะสมในการปรับปรุงการบริหารยาและการสั่งยา (เช่น patient and peer review feedback, prescribing data and analysis and audit)

10. สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นแบบสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Prescribe as part of a team)

10.1 มีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันในทุกหน่วยโดยไม่ขัดแย้ง

10.2 สร้างสัมพันธภาพกับทีมสหวิชาชีพ บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และยอมรับในบทบาทของสหวิชาชีพ

ประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาล 17 ประเด็น ดังนี้

1) National Drug Policy (NDP) and concepts of RDU	1) นโยบายยาแห่งชาติ (NDP) และแนวความคิดของ RDU
2) Basic pharmacology (Pharmacodynamics) and Clinical pharmacokinetics	2) เภสัชวิทยาพื้นฐาน (เภสัช) และเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
3) Irrational/ inappropriate use of medicine	3) การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล/ ไม่เหมาะสม
4) Monitoring and evaluation impact of drug therapy	4) การติดตามและประเมินผลกระทบของการบำบัดด้วยยา
5) Adherence to treatment	5) การปฏิบัติตามการรักษา
6) Benefit-risk and cost assessment and decision making in prescription	6) การประเมินผลประโยชน์-ความเสี่ยงและต้นทุนและการตัดสินใจในใบสั่งยา
7) RDU in common illness	7) RDU ในความเจ็บป่วยทั่วไป
8) Taking an accurate and informative drug history	8) การซักประวัติยาที่ถูกต้องและให้ข้อมูล
9) Administer drug safely	9) ใช้ยาอย่างปลอดภัย
10) Medication errors	10) ข้อผิดพลาดของยา
11) Prescribing for patients with special requirements	11) การกำหนดให้ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
12) Provide patients and careers with appropriate information about their medicines	12) ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและอาชีพเกี่ยวกับยา
13) Awareness of rational approach to prescribing and therapeutics	13) ความตระหนักในแนวทางที่มีเหตุผลในการสั่งจ่ายยาและการรักษา
14) Ethics of prescribing and drug promotion	14) จรรยาบรรณในการสั่งยาและส่งเสริมยา
15) Complementary and alternative medicine	15) ยาเสริมและการแพทย์ทางเลือก
16) Multi-professional care team to improve drug use	16) ทีมงานดูแลมืออาชีพ ปรับปรุงการใช้ยา
17) Continuous professional development in RDU	17) การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องใน RDU

กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 10 ข้อ

- 1.ข้อบ่งชี้ (Indication) ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น (เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ)
2. ประสิทธิภาพ (Efficacy) ยานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยอาจพิจารณาจากกลไก การออกฤทธิ์ มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพียงพอ
- 3.ความเสี่ยง (Risk) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักมีประโยชน์มากกว่าโทษ และไม่มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วย
- 4.ค่าใช้จ่าย (Cost) ใช้ยาอย่างพอเพียงและคุ้มค่า
- 5.องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น (Other considerations) รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง รับผิดชอบและใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานทางวิชาการ
- 6.ขนาดยา (Dose) ใช้ยาถูกขนาด
- 7.วิธีให้ยา (Method of administration)
- 8.ความถี่ในการให้ยา
- 9.ระยะเวลาในการให้ยา (Duration of treatment)
10. การยอมรับของผู้ป่วยและความสะดวกในการใช้ยา (Patient compliance)

หัวข้อการสอน การพยาบาลผู้ป่วยใช้ยาสมเหตุผล

สมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลที่กำหนด

1. สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา
 - 1.1 การประเมินประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา และประวัติการแพ้ยา/แพ้ อาหาร
 - 1.2 ประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
 - 1.3 ประเมินอาการที่ดีขึ้นหรือเลวลง
 - 1.4 ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา อย่างต่อเนื่อง
4. บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
 - 4.1 เข้าใจโอกาสที่จะเกิดผลไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา และดำเนินการเพื่อ หลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตระหนักและจัดการแก้ไขปัญหา

ประเด็นเนื้อหาหลักที่กำหนด (เลือกจาก 17 ประเด็นเนื้อหาหลัก)

4. Monitoring and evaluation impact of drug therapy, adverse effects properly and reporting drug related problems

5. Adherence to treatment

9. Administer drug safely

กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1. ข้อบ่งชี้ (Indication) ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น (เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ)

2. ประสิทธิภาพ (Efficacy) ยานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยอาจพิจารณาจากกลไก การออกฤทธิ์ มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพียงพอ

6. ขนาดยา (Dose) ใช้ยาถูกขนาด

ผลการเรียนรู้ที่กำหนด

1. มีความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสื่อสารการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับผู้ป่วยและครอบครัวได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายโอกาสของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา

2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

1. บรรยายเรื่องการบริหารยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วย (10 นาที)

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละไม่เกิน 10 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายในประเด็น โอกาสและการป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ข้อพึงระวังและอาการแสดงที่สำคัญ ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการใช้ยา และการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (20 นาที)

3. สุ่มนักศึกษาเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นที่มอบหมาย อาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษายังอธิบายเหตุและผลไม่ชัดเจน/ไม่ถูกต้อง

4. สุ่มนักศึกษาให้แสดงบทบาทสมมติหัวข้อ การสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (10 นาที)

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม(10 นาที)

6. ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ (10 นาที)

สื่อการสอน

1. ใบงาน
2. กรณีศึกษา
3. กระดาษ Flip chart
4. Power point และเอกสารประกอบการเรียนในระบบ e learning
5. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ได้ใจความของคำตอบในใบงาน
2. Quiz เมื่อสิ้นสุดการสอน

ตัวอย่างกรณีศึกษา

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 43 ปี การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถานภาพสมรส คู่
อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล อาเจียนและอุจจาระเป็นสีดำนมา 3 วัน ทานอาหารไม่ได้และอ่อนเพลีย
การวินิจฉัยโรค Warfarin Overdose

ประวัติเจ็บป่วยในอดีต DM type II , DLP, stroke and CKD stage III ได้รับยา warfarin 2 mg. 1 tab hs.

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ PT 50.4; INR 4.32; Hb 10.1 mg%; Hct. 30.3 %

การรักษา รับไว้ในโรงพยาบาล

- งดยา Warfarin
- Repeat PT/INR q 12 hrs.
- Observe Vital signs q 4 hrs. and notify if changes.

แนวทางการอภิปราย สมรรถนะการใช้อยาสมเหตุผลที่ 1 , 4

ประเด็นเนื้อหาหลักข้อที่ 4 , 5 , 9

กรอบแนวคิดที่ 1 , 2 , 6

1. สรรพคุณของยา Wafarin และผลข้างเคียงของยา อาการและอาการแสดงเมื่อขาดยาหรือ ได้รับยามากเกินไป
2. ประวัติการใช้ยา พฤติกรรมการกินยา การซื้อยากินเอง
3. การสื่อสารกับผู้ดูแลในการใช้ยา การจัดยาให้ผู้ป่วยและการสังเกตอาการที่เกิดจาก ผลข้างเคียงของการใช้ยา

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์

Warfarin เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Oral anticoagulant) ใช้ในการรักษาและป้องกันภาวะ thromboembolism

warfarin ออกฤทธิ์เป็น vitamin K antagonist ในกระบวนการ carboxylation ของ factor II, VII, IX และ X ใน coagulation cascade

ความสำคัญคือ warfarin เป็นยาที่มี bioavailability สูง แต่ therapeutic range แคบ นอกจากนี้ยังพบ drug-drug interaction และ food-drug interaction ได้บ่อย

การตอบสนองของยา warfarin ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อาหารที่มีวิตามินเคปริมาณมาก การออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง (noncompliance) การใช้ยาอื่นร่วมที่มีผลต่อระดับยา warfarin หรือสภาวะที่ผู้ป่วยมีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคตับ ภาวะขาดสารอาหาร และภาวะไต เป็นต้น ดังนั้นขนาดของยาในแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกัน ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังและเจาะเลือดติดตามอย่างใกล้ชิด

ข้อปฏิบัติในการรับประทานยาวาร์ฟาริน

1. ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่เพิ่ม ลด หรือหยุดยาเอง ควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยรับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้นเคยและช่วยให้ไม่ลืมรับประทาน สามารถรับประทานยาก่อน หรือหลังอาหารได้ เนื่องจากยาไม่มีผลระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และควบคุมปริมาณอาหารชนิดพืช ผักใบเขียวที่รับประทานให้ สม่ำเสมอ ไม่ควรรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป
3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ระดับยาวาร์ฟารินในเลือดเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารเสริม หรือสมุนไพรชนิดต่าง ๆ
4. หลีกเลี่ยงกีฬาหรือกิจกรรมที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเลือดออกง่าย ควรใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม ควรใช้แผ่นกันลื่นบริเวณห้องน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
5. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดบาดแผล เลือดอาจออกไม่หยุด หากบาดแผลมีขนาดเล็กและไม่ลึก วิธีแก้ไข คือ ใช้มือสะอาดกดไว้ให้แน่นตรงบาดแผล เลือดจะหยุดหรือออกน้อยลง หากเลือดยังไม่หยุดไหล ให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีและแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบว่ารับประทานยาวาร์ฟารินอยู่
6. หากต้องทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น ทำฟัน หรือผ่าตัด ต้องบอกให้ทันตแพทย์หรือแพทย์ ผู้รักษาทราบว่ากำลังรับประทานยาวาร์ฟาริน โดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องทำการผ่าตัด ถอนฟัน หรือต้องรับประทานยาอย่างอื่นเพิ่ม เนื่องจากมียาหลายชนิดที่เพิ่มฤทธิ์หรือลดฤทธิ์ของยาวาร์ฟาริน
7. กรณีเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้งและห้ามรับการรักษาโดยการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

8. ควรพบสมุดประจำตัวเมื่อได้รับยารวาร์ฟาริน ติดตัวไว้เพื่อเป็นการดูแลตนเองและแสดงสมุดทุกครั้ง ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสุขภาพ เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ทราบ

9. หากลิ้มรับประทานยาที่มีข้อปฏิบัติคือ ห้ามเพิ่มขนาดยาที่รับประทานเป็น 2 เท่าโดยเด็ดขาดและปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรณีลิ้มรับประทานยาและยังไม่ถึง 12 ชั่วโมงให้รับประทานยาทันทีในขนาดเท่าเดิม

- กรณีลิ้มรับประทานยาและเลย 12 ชั่วโมงไปแล้ว ให้ข้ามยาในมือนั้นไป แล้วรับประทานยามื้อต่อไปในขนาดเท่าเดิม

10. การเก็บรักษายา เก็บให้พ้นแสงและความชื้นและเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

11. ยานี้มีผลต่อทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ดังนั้นหากท่านตั้งครรภ์ หรือมีโครงการจะมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์

12. ยานี้สามารถขับผ่านทางน้ำนมได้ ดังนั้นหญิงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร ก่อนใช้ยานี้ การสังเกตอาการผิดปกติ ได้แก่ เลือดออกตามไรฟัน จำเลือดตามตัว เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกทางทวารหนัก อุจจาระมีสีดำ มีเลือดออกที่ช่องคลอด หรือประจำเดือนมามากผิดปกติ ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดศีรษะมาก แขนขาอ่อนแรง หมดสติ พุดไม่ชัด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้ามีอาการดังกล่าว ให้หยุดยาที่รับประทานและรีบมาโรงพยาบาล

การติดตามผลการรักษา

1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการเจาะเลือดเพื่อวัดการแข็งตัวของเลือด และให้แพทย์ได้ปรับยาให้เหมาะสม กับผู้ป่วยแต่ละราย

2. หลังจากออกจากโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะต้องมาตรวจตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษาและ ปรับระดับยา

3. เมื่อระดับยาคงที่แล้ว ควรเจาะเลือดเพื่อวัดการแข็งตัวของเลือดทุกครั้ง โดย แพทย์จะนัดตรวจทุก 1-3 เดือน

Quiz

ผู้ป่วยอายุ 78 ปีรายหนึ่ง มาพบแพทย์ 2 แผนก ในวันเดียวกัน แพทย์อายุรกรรมสั่ง tramadol (50 มก.) 1 เม็ด ทุก 8 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวด จำนวน 30 เม็ด แพทย์แผนกโรคข้อและกระดูกสั่งยา Ultracet® (tramadol 37.5 มก. + paracetamol 325 มก.) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง จำนวน 30 เม็ด จากประวัติพบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดข้อ และเพิ่งมีอาการเป็นครั้งแรก ยังไม่ทราบการวินิจฉัยที่แน่ชัด ผู้ป่วยมีค่า eGFR = 28 mL/min/1.73 m² ท่านจะให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างไร

1. ให้ใช้ยาของแพทย์อายุรกรรมเพียงอย่างเดียว โดยให้ใช้ตามขนาดที่แพทย์สั่ง
2. ให้ใช้ยาของแพทย์อายุรกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ให้ลดขนาดยาลงเป็นวันละไม่เกิน 2 ครั้ง ห่างกัน อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
3. ให้ใช้ยาของแพทย์แผนกกระดูกและข้อเพียงอย่างเดียว โดยให้ใช้ตามขนาดที่แพทย์สั่ง
4. ให้ใช้ยาของแพทย์แผนกกระดูกและข้อเพียงอย่างเดียว แต่ให้เพิ่มขนาดยาเป็นครั้งละ 2 เม็ด เนื่องจากได้พาราเซตามอลในขนาดต่ำเกินไป

เฉลย 2.

เหตุผล การกินยาจากทั้งสองแผนกพร้อมกันเป็นการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน เพิ่มผลข้างเคียงจากยาโดยไม่ได้ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยมี eGFR < 30 mL/min/1.73 m² ควรให้ยาห่างกันทุก 12 ชั่วโมง ควรหลีกเลี่ยงยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Ultracet) และหลีกเลี่ยงการใช้ยาผสมเมื่อใช้ยาเดี่ยวทดแทนได้

ประเด็น RDU ที่ประเมิน ความเสี่ยงจากการใช้ยา การใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน การปรับขนาดยา special population (elderly และ renal impairment) บัญชียาหลักแห่งชาติ